

УДК: 616-006.6

М.А.Кайназарова, Г.Б.Адилбаев, О.Ю.Трущенко

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕКОЙ КАРТИНЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация. Что надо знать практикующему врачу?

Опухоли слезных желез – это группа опухолевых поражений орбиты неоднородного строения, встречаются нечасто, примерно 7.5 % от всех новообразований орбиты. Данная патология представляет трудности, как в плане диагностики, так и в лечении. Поскольку часто маскируется под другие неопухолевые заболевания.

Цель исследования- провести анализ эффективности лечения у пациентов со злокачественными опухолями слезной железы. Для чего поставлена задача - провести ретроспективный анализ историй болезни 12 пациентов с опухолями слезной железы, проходивших лечение в центре опухолей головы и шеи КазНИИ онкологии и радиологии с 2010 по 2016 гг. Материал и методы – из 12 пациентов: женщин- 7, мужчин- 5, в возрасте от 28 до 76 лет. Все пациенты были с рецидивными новообразованиями орбиты и ранее получали хирургическое лечение в различных медицинских учреждениях республики и ближнего зарубежья. По гистологической картине распределение больных выглядело следующим образом: плеоморфная аденома-1 пациентка, рак в плеоморфной аденоме-2. Первичный аденокистозный рак, аденокарцинома слезной железы- 5.

Результаты. Всем 12 больных в разные сроки лечения произведена поднадкостничная экзентерация орбиты, 3-е пациентов получили ПХТ, 4-м лечение комбинировалось лучевой терапией на послеоперационное ложе опухоли (орбита) и зону регионарного метастазирования. 2-е пациентов за время наблюдения умерло в связи с прогрессированием процесса и развитием метастазов в головной мозг. 5-летняя выживаемость пациентов со злокачественными опухолями слезной железы после проведения комбинированного лечения составила 75 %. Выводы. Злокачественные опухоли слезной железы имеют агрессивное течение и часто рецидивируют. Хирургическое лечение рецидивных процессов включает в себя локальное удаление опухоли с сохранением глазного яблока, которое не всегда гарантирует радикальность лечения и поднадкостничную экзентерацию орбиты, как показывает наш практический опыт, это наиболее эффективное хирургическое лечение данной категории пациентов. Наибольший противоопухолевый эффект и 5-летняя выживаемость в 75 % достигается комбинированным лечением: экзентерация орбиты + высокотехнологичная лучевая терапия.

Ключевые слова: слезная железа, злокачественные опухоли слезной железы, экзентерация орбиты, экзофтальм, конформная лучевая терапия.

Слезная железа – это парный секреторный орган, ко-

торый вырабатывает слезную жидкость. Железа имеет характерную вогнутую форму, т.к. находится в углублении между наружной стенкой глазницы и глазом (т.н. ямка железы). В норме ткань железы недоступна для пальпации, только небольшая ее часть при вывороте верхнего века может визуализироваться сквозь конъюнктиву. Средний размер железы 10х20х5 мм. Вес составляет 0,75-0,80 г. Слезная железа состоит из двух долей: верхней, также называемой глазничной (большей по объему) и нижней – так называемой пальпебральной (меньшей по объему). Между ними находится апоневроз мышцы, поднимающей верхнее веко, прерываемый небольшим мостиком паренхимы. Каждая доля имеет альвеолярно-трубчатое строение, состоит из нескольких долек, разделенных соединительной тканью. От каждой доли отходит 5-6 протоков, объединяющихся в один главный.

Микроскопическое строение схоже с таковым околушной железы. Каждая долька содержит секреторные клетки, заполненные гранулами серозного секрета. В просвет протока они поступают путем экзоцитоза (т.е. содержимое выплескивается наружу после слияния стенки гранулы с клеточной стенкой). Вокруг секреторных клеток находятся модифицированные мышечные волокна, которые обеспечивают выделение секрета. Из клеток образуются скопления — ацинусы, переходящие в протоки, стенки которых покрыты плоским эпителием. Эти протоки открываются в конъюнктивальный мешок, а при закрытых глазах стекает по слезному ручью, расположенному у края века. Далее они поступают к внутреннему углу глаза, а затем фильтруются в слезоотводящие органы.

Функция слезной железы, как секреторного органа: обеспечение поступления питательных соединений к главному яблоку путем диффузии; очищение глаза от попавших мелких частиц; увлажнение глазного яблока; антибактериальный эффект за счет присутствия в слезе лизоцима. Реализация этих функций происходит при выработке слезной жидкости и ее дальнейшего поступления в конъюнктивальный мешок.

Опухоли слезных желез – группа опухолевых поражений слезной железы неоднородного строения. Происходят из железистого эпителия, представлены эпителиальным и мезенхимальным компонентом. Относятся к категории смешанных новообразований. Встречаются редко, диагностируются у 12 из 10000 пациентов. По данным А.Ф. Бровкиной на долю опухолевых заболеваний слезной железы приходится примерно 7.5 % от всех новообразований орбиты.

В 50% случаев среди всех опухолей слезной железы составляет плеоморфная аденома, которая может реци-

дивировать и малигнизировать уже при первом рецидиве. Чем меньше срок ремиссии – тем больше вероятность озлокачествления рецидивной опухоли.

Какое-то время опухоль слезной железы существует, не доставляя особых неудобств пациенту, затем ее рост ускоряется. В области века появляется воспалительный отек. Из-за давления растущего узла развивается экзофтальм и смещение глаза кнутри и книзу. Более чем у половины пациентов признаки малигнизации выявляются уже при первом рецидиве. Чем меньше срок ремиссии – тем больше вероятность озлокачествления рецидивной опухоли.

Рак в плеоморфной аденоме и первичный аденокистозный рак слезной железы составляют более 60 % от раков слезой железы. Чаще развиваются у женщин, быстро растут и имеют неблагоприятный прогноз для зрения и жизни. Опухоль склонна к рецидивированию с проращением в полость черепа, придаточные пазухи носа, кожу. Метастазирует в регионарные лимфатические узлы, легкие, позвоночник. Временной период между появлением первичной опухоли и возникновением отдаленных метастазов может составлять от 1-2 до 20 лет. Большинству пациентов не удается преодолеть пятилетний порог выживаемости.

Не смотря на редко встречаемую опухоль орбиты, данная патология представляет трудности, как в плане диагностики, так и в лечении. Поскольку часто маскируется под другие неопухолевые заболевания. И при первичном обращении пациентов к офтальмологам ошибочно выставляется диагноз дакриoadенит, псевдотумор орбиты и даже халязион век. Длительная консервативная терапия, применение тепловых процедур, а также неадекватный объем хирургического лечения приводит к запущенности опухолевого процесса.

Цель - провести анализ эффективности лечения у пациентов со злокачественными опухолями слезной железы.

Задача- провести ретроспективный анализ историй болезни 12 пациентов с опухолями слезной железы, проходивших лечение в центре опухолей головы и шеи КазНИИ онкологии и радиологии с 2010 по 2016 гг.

Материал и методы - среди 12 пациентов женщин было больше (7 человек), мужчин- 5 человек, в возрасте от 28 до 76 лет. Все пациенты были с рецидивными новообразованиями орбиты и ранее получали хирургическое лечение в различных медицинских учреждениях республики и ближнего зарубежья.

По гистологической картине распределение больных выглядело следующим образом: плеоморфная аденома-1 пациентка, рак в плеоморфной аденоме-2. Первичный аденокистозный рак, аденокарцинома слезной железы- 5.

Результаты. Анализ особенностей клинического течения первичных новообразований орбиты позволил установить, что первичные злокачественные новообразования слезной железы характеризовались короткими сроками от предполагаемого начала заболевания до обращения к врачу (6,8+3,75 месяцев). Дебют заболевания отмечался комбинацией нескольких симптомов: экзофтальм со смещением вниз и к носу, ограничение движения глазного яблока, птоз верхнего века, пальпаторно определяемых опухолевидных образований в области верхнего века. У 2-х больных рецидив опухоли в орбите возник че-

рез 1,5 месяца после нерадикально проведенной операции (орбитотомия с удалением образования орбиты). При повторном обращении уже в онкологический стационар у данных пациентов помимо вышеуказанных симптомов отмечался «красный» хемоз конъюнктивы, боли на стороне поражения, а также боли неврологического характера в области лба, обусловленные воздействием новообразования на ветви тройничного нерва.

У 9-ти пациентов рецидив появился через 2,7+0,3 лет после комбинированного лечения (операция+лучевая терапия СОД 40 Гр). Химиотерапию в адъювантном режиме в ООД получили 3 больных. Один больной неоднократно был оперирован, включая экзентерацию орбиты, в связи с 3-мя эпизодами рецидивного процесса в орбите.

При первичных опухолях при пальпации верхнего века определялся неподвижный, безболезненный, плотный гладкий узел. Однако при рецидивах опухоль пальпировалась не только в проекции слезной железы, но и в виде подковообразного валика вокруг глазного яблока, заполняя большую часть орбитального пространства вплоть до вершины орбиты. Установлено, что основными компьютерно-томографическими признаками злокачественных данных новообразований являлись: преимущественная локализация в наружном хирургическом пространстве, в верхне-латеральном углу орбиты, неправильная форма, неоднородность структуры за счет наличия низкоплотных (гиподенсных) участков, нечеткие неровные контуры, отсутствие капсулы, мягкотканая плотность. Инфильтрация параорбитальных мышц, ретробульбарного пространства, наличие многоузлового образования с бугристыми контурами, деструкция и истончение прилегающих костных стенок орбиты характеризовались при продолженном росте и рецидивах опухоли.

Учитывая агрессивный рост и рецидивный характер опухоли всем 12 пациентам была выполнена операция – поднадкостничная экзентерация орбиты.

Двоим больным предварительно была попытка провести органосохранное лечение в объеме: костно-пластической орбитотомии с удалением рецидивной опухоли орбиты. Однако через 2 месяца, из-за повторного роста опухоли в орбите, мы вынуждены были прибегнуть к радикальной операции – поднадкостничной экзентерации орбиты, что еще раз подчеркивает агрессивность течения этой опухоли.

Больным со злокачественными опухолями слезной железы (4 человека) хирургическое лечение было дополнено лучевой терапией- КФЛТ, IMRT(RapidArk) , IGRT. В планируемый объем облучения включалось послеоперационное ложе опухоли(орбита) РОД 2 Гр до СОД 66-70 Гр, 5 фракций в неделю.

Критическими органами считаются: глазное яблоко(R и L), зрительные нервы(R и L), хиазма зрительных нервов, зрачки(R и L), ствол мозга. Для того чтобы критические органы не получили большую дозу облучения и РОД не превышала максимально допустимую дозу при доставке пучка высокоэнергетических рентгеновских лучей к опухоли, критические органы закрывались лепестками коллиматора. При дообследовании на этапах госпитализации часто выявляются метастатические поражения регионарных лимфоузлов, которые включаются в зону облучения при стандартных дозах РОД 2-2,2 Гр, СОД 66-70

Гр (зоны повышенного риска, т. е непосредственно на метастазы лимфоузлов), среднего риска-66Гр- прилежащие зоны лимфоузлов, зоны низкого риск(отдаленные зоны лимфоузлов)-54Гр. Помимо основного очага из 4 пациентов, получивших лучевую терапию, 3 пациента получили ЛТ и на зону регионарных лимфатических узлов, в связи с установленными метастазами в различные зоны шеи и околоушной области на стороне поражения. У всех этих

пациентов достигнута полная регрессия мтс-поражения регионарных лимфоузлов.

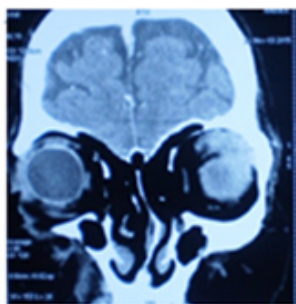
Из 12 пациентов 2 пациентов умерло в связи с прогрессированием процесса и развитием метастазов в головной мозг.

5-летняя выживаемость пациентов со злокачественными опухолями слезной железы после проведения комбинированного лечения составила 75 %.

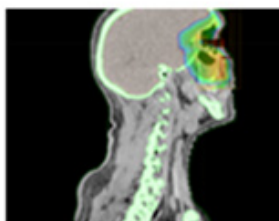
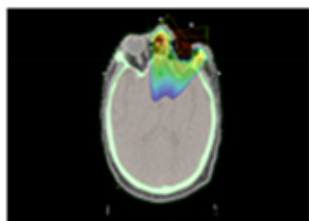
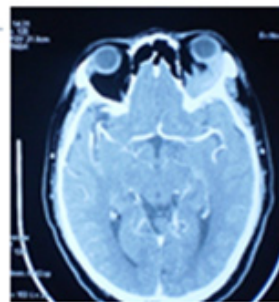
Б-ной Х. 64г, д-з :С-г слезной железы слева T2N0M0 St II. Сост после хир лечения (2013 г). Рецидив. Операция 03.12.15 : Экзентерация орбиты слева.



Вид пациента с рецидивом аденокарциномы слезной железы. Полный птоз, экзофтальм слева, боли в орбите



Кт-картина рецидива С-г левой слезной железы с инфильтрацией параорбитальных мышц, ретробульбарной клетчатки, склеры левого глазного яблока и инфильтрацией оболочек зрительного нерва



Схемы планирования послеоперационной 3-D конформной лучевой терапии у этого пациента

Выводы. Таким образом, злокачественные опухоли слезной железы имеют агрессивное течение и часто рецидивируют. Хирургическое лечение рецидивных процессов включает в себя локальное удаление опухоли с сохранением глазного яблока, которое не всегда гарантирует радикальность лечения и поднадкостничную экзентерацию орбиты, как показывает наш практический опыт,

наиболее эффективное хирургическое лечение данной категории пациентов.

Наибольший противоопухолевый эффект и 5-летняя выживаемость в 75 % достигается комбинированным лечением: экзентерация орбиты + лучевая терапия (КФЛТ, IMRT(RapidArk), IGRT).

Список литературы

- 1.Амирян А.Г. Опухоли слезной железы: особенности клинической картины в начале их роста // Сборник научных трудов международного симпозиума «Заболевания, опухоли и травматические повреждения орбиты».-М., 2005.-55с.
- 2.Бровкина А.Ф. Офтальмоонкология.- М., 2002.- С. 364-370.
- 3.Зотова А.С. Первичные новообразования орбиты: структура и алгоритмы клинко-лучевой диагностики... автореферат дисс., 2008.
- 4.Стешенко О.Н. Свойства слезы и ее продукция при заболеваниях слезной железы...автореферат дисс., 2014.
- 5.http://GlazKakAlmaz.ru/wp_content/uploads/2015/01/Sleznaya_zheleza_1.jpg.
- 6.<http://yaviju.Com/stroenie-glaza/sleznaya-zheleza-glavnyi-uvlazhnitel-glaza.htm>.
- 7.Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. September 2010.Volume 248 Issue pp1345-1349/ Epithelial tumors of the lacrimal gland in Chinese a Clinicopathologic study of 298 patiens.
- 8.Heaps R.S., Miller N.R. ,Albert D.M. et all. Primary adenocarcinoma of the lacrimal gland. A retrospective study. Ophthalmology.-1993.-Vol.100.-P.1856-1860.
- 9.Rose G.E., Wright J.E. Pleomorphic adenoma of the lacrimal gland // Br. J. Ophthalmol.-1992.-Vol. 76.-P.395-400.
10. Shields J.A., ShieldsC.L., Epstein J.A. et all. Review primary epithelial malignances of the lacrimal gland the 2003 Ramon L //Fond Lecture. Ophthal. Plast Reconstr Surg.-2004.-Vol. 20.- P.10-21

Тұжырым.

М.А.Кайназарова, Г.Б.Адильбаев, О.Ю.Трущенко
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

**КӨЗЖАС БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ КӨРІНІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

Тәжірибелік дәрегер не білуі қажет? Көзжас безінің ісіктері бұл – орбитаны зақымдайтын, біртекті құрылымды, сирек кездесетін, орбита ісіктерінің ішінен 7,5%-ды құратын ісіктер тобына жатады. Бұл патология диагностика жағынан, және де ем жағынан қиындықтар туғызады. Себебі басқа ісіктік емес аурулармен жасырың түрде өтеді.

Зерттеудің мақсаты – көзжас безінің қатерлі ісігі бар науқастарда ем тиімділігінің анализін жүргізу. Зерттеудің міндеті – 2010-2016жж. аралығындағы ҚазОПФЗИ бас және мойын ісіктер орталығындағы емделген 12 науқастың ауру тарихының ретроспективті анализін жүргізу. Мәліметтер мен әдістемелер – 12 науқастың ішінен: 7-әйел, 5-еркек, жасы 28 бен 76 аралығында. Барлық науқастар орбитаның рецидивті ісіктерімен болған, сонымен қатар барлық науқастар жақын шетелде және республикамыздың әр түрлі медициналық мекемелерінде хирургиялық ем алған. Науқастарды гистологиялық көрінісі бойынша былай жіктеді: плеоморфты аденомамен-1 науқас, плеоморфты аденомадағы қатерлі ісік-2. Біріншілік аденокистозды қатерлі ісік, көзжас безінің аденокарциномасы- 5.

Нәтижелер. Барлық 12 науқасқа әр түрлі ем мерзімінде орбитаның сүйек тысы асты экзентерациясы жасалған, 3-науқас ПХТ алған, 4-науқасқа біріктіріле ісіктің орнына (орбита) және де жергілікті метастаздау аймақтарына сәулелік терапия жүргізілді. Бақылау барысында 2-науқас ісіктік процесстің үдеуіне және бас миына метастаз беруіне байланысты қаза болды. Көзжас безінің қатерлі ісігі бар науқастарда жүргізілген біріктірілген емнен кейінгі 5-жылдық өміршендік 75%-ды құрды.

Қорытынды. Көзжас безінің қатерлі ісігі көбіне агрессиялық ағымды және жиі рецидив береді. Рецидивті процесстердің хирургиялық емінің мақсаты – көз алмасын сақтап жергілікті ісікті алу, бірақ бұл әдіс үнемі емнің радикалдылығына кепілдік бермейді. Біздің тәжірибеміз көрсеткендей орбитаның сүйек тысы асты экзентерация операциясы бұл топ науқастарда ең тиімді хирургиялық емнің бірі болып саналады. 75%-да ісікке қарсы тиімділік пен 5-жылдық өміршендік көпшілікті біріктірілген ем (орбитаның экзентерациясы + жоғары-технологиялық сәулелік терапия).

Түйінді сөздер: көзжас безі, көзжас безінің қатерлі ісігі, орбитаның экзентерациясы, экзофтальм, конформды сәулелік терапия.

Summary

M.A.Kainazarova, G.B.Adilbaev, T.U.Trushenko
Kazakh Institute of Oncology and Radiology, center head and neck tumors,

Features of clinical diagnostic picture of malignant tumors of the lacrimal gland. What does the practitioner need to know ?

Tumors of the lacrimal glands - a group of neoplastic lesions of the inhomogeneous structure of the orbits are rare, approximately 7.5% of all tumors of the orbit. This pathology presents difficulties both in terms of diagnosis and treatment. As it is often masquerades as other non-tumor disease. The purpose of research is to conduct our analysis of the effectiveness of treatment in patients with malignant tumors of the lacrimal gland. For this task we carried out a retrospective analysis of medical records of 12 patients with tumors of the lacrimal gland, treated in our center of the head and neck tumors from 2010 to 2016. Material and Methods - 12 patients: 7 women, 5 - male, in the ages of 28 to 76 years. All patients were with recurrent tumors of orbit and had previously received surgical treatment in different medical institutions of the republic and abroad. According to the histological picture of the distribution of the patients was as follows: pleomorphic adenoma-1 patient, a cancer in pleomorphic adenoma-2. adenoid cystic cancer, primary adenocarcinoma - 5. Results. All 12 patients in different periods of treatment had been made subperiosteal exenteration of the orbit, 3 patients received chemotherapy, 4 patients were treatment with radiotherapy on postoperative tumor bed (orbit) and a zone of regional metastasis. 2 patients died during follow-up in connection with the progression of the process and the development of brain metastases. After the combined treatment there were 75% of 5-year survival rates of patients with malignant tumors of the lacrimal gland. Conclusions. Malignant tumors of the lacrimal gland have an aggressive course and often recur. Surgical treatment of recurrent processes includes local removal of the tumor with preservation of the eyeball, which does not always guarantee a radical treatment.

Surgical treatment of recurrent processes includes local removal of the tumor with preservation of the eyeball, which does not always guarantee a radical treatment and subperiosteal exenteration of the orbit, according to our experience, this is the most effective surgical treatment of these patients. The greatest anti-tumor effect and the 5-year survival rates of 75% is achieved by the combined treatment: exenteration of orbit + high-tech radiation therapy.

Keywords: lacrimal gland, malignant tumors of the lacrimal gland, exenteration of the orbit, exophthalmos, conformal radiotherapy.